令和8年6月施行

令和8年度 診療報酬改定

【神経内科編】

認知症・リハビリ・遠隔診療・難病の主要変更点

厚生労働省公式資料・疑義解釈に基づく

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

神経内科領域の主要改定ポイント

1. **認知症地域包括診療の統合・再編**
   認知症患者区分で高い点数設定、要介護者は1疾患でOK
2. **早期リハ加算の大幅見直し**
   入院3日以内 25点→60点、算定期間30日→14日に短縮
3. **休日リハビリ加算【新設】**
   1単位25点 — 脳卒中365日リハ体制を後押し
4. **遠隔連携診療料 — 指定難病に拡大**
   全指定難病900点/月 — 神経難病の遠隔医療
5. **回復期リハ病棟の基準見直し**
   実績指数40→42、FIM認知除外14点以下に厳格化
6. **離床なきリハの減算・AI活用ほか**
   ベッド上リハ10%減算、生成AI 1.2倍換算

認知症地域包括診療の統合・再編

「認知症地域包括診療加算/料」が通常の「地域包括診療加算/料」に統合

地域包括診療加算（再診時）

	認知症患者等	その他
加算1	38点	28点
加算2	31点	21点

地域包括診療料（月1回）

	認知症患者等	その他
診療料1	1,682点	1,661点
診療料2	1,614点	1,601点

実務上の重要ポイント

- 要介護者は1疾患でも算定可能に（従来2疾患以上）
- 認知症の診断後支援 — 地域包括支援センターとの連携を明記
- 外来データ提出加算（月1回10点）が新設

早期リハビリテーション加算の大幅見直し

算定時期	改定前	改定後	変化
入院3日以内	25点	**60点**	**+35点（2.4倍）**
4日目〜14日目	25点	25点	据置
算定可能期間	入院から30日目	**入院から14日目**	16日短縮

注意点

- 転院患者は転院前の入院日が起算日
- 外来患者（退院後）は退院前の入院日が起算日
- 「超急性期72時間に集中的にリハを入れる」インセンティブの明確化

休日リハ加算【新設】＋ 遠隔連携診療料の拡大

休日リハビリテーション加算

- 休日にリハビリ実施で 1単位25点 加算
- 発症/手術から7日目 or
  治療開始から30日目まで
- 脳卒中365日リハ体制を評価

遠隔連携診療料の対象拡大

- 全指定難病が対象に追加
- 外来/訪問/入院 各900点/月
- 医療受給者証の有無を問わず
- 軽症者も対象

遠隔連携診療の対象となる主な神経難病

ALS（筋萎縮性側索硬化症） / パーキンソン病 / 多発性硬化症
脊髄小脳変性症 / 重症筋無力症 / 多系統萎縮症
進行性核上性麻痺 / ハンチントン病 / CIDP ほか全指定難病

D to P with N — 看護師同席のオンライン診療

看護師が実施可能な項目

- 検査（採血等） → 検査実施料を算定
- 注射 → 注射実施料を算定
- 処置 → 処置実施料を算定

神経内科での活用シナリオ

- ALS在宅患者の定期フォロー
- パーキンソン病の服薬調整
- 遠隔地の神経難病患者に
  訪問看護と専門医を橋渡し

回復期リハ病棟の基準見直し ①入院料・実績指数

区分	改定前	改定後	増点
入院料1	2,229	**2,346**	+117
入院料2	2,166	**2,274**	+108
入院料3	1,917	**2,062**	+145
入院料4	1,859	**2,000**	+141
入院料5	1,696	**1,794**	+98

区分	改定前	改定後
入院料1	40以上	**42以上**
入院料2	未設定	**32以上**
入院料3	35以上	**37以上**
入院料4	未設定	**32以上**

回復期リハビリテーション強化体制加算【新設】

- 1日につき 80点（入院料1対象）
- 実績指数 48以上 が要件
- 退院前訪問指導の実績＋排尿自立支援加算の届出が必要

回復期リハ病棟の基準見直し ②重症患者・除外基準

緩和された基準

- 重症患者割合
  入院料1・2: 4割 → 3.5割
  入院料3・4: 3割 → 2.5割
- 「退院時3割改善」要件を 削除

厳格化された基準

- 80歳以上の除外規定 → 廃止
- FIM認知除外: 24点以下→14点以下
- 除外割合上限: 3割→2割
- 実績指数下限: 27→30

重症患者の新定義

以下のいずれか：

① 日常生活機能評価10点以上 または FIM総得点21点以上55点以下
② 高次脳機能障害と診断された患者
③ 脊髄損傷と診断された患者

離床なきリハの減算 ＋ 特定疾患療養管理料

離床なきリハビリの減算【新設】

・所定点数の 90%で算定
（10%減算）
・1日2単位まで に制限
・医学的理由がある場合は除外可能
→ カルテ記載が重要

特定疾患療養管理料の変更

・ギラン・バレー症候群は
引き続き対象
・長期処方/リフィル処方箋の
掲示義務を追加
・胃十二指腸潰瘍にNSAIDs除外

離床なきリハ減算 — 影響を受ける神経疾患患者

・重症脳卒中（意識障害・高度片麻痺）、ALS・進行性筋疾患
・ただし「医学的理由がある場合」は除外
→ 診療録に理由を記載し、離床困難な医学的根拠を明確にする

ベースアップ評価料の拡充 ＋ AI・ICT活用

場面	R6参考	R8（新規）	R8（継続）
初診時	6点	**17点**	**23点**
再診時	2点	4点	**6点**
訪問診療	28点	79点	**107点**

生成AI活用の評価

医師事務作業補助者
- AI文書作成 → 1.2倍換算
- AI＋音声入力 → 1.3倍換算

令和9年度にはベースアップ評価料が さらに200%（2倍）に引き上げ予定

電子的診療情報連携体制整備加算【新設】

初診: 加算1 15点 / 加算2 9点 / 加算3 4点　　再診: 2点

まとめ — 神経内科へのインパクト

プラスの影響

- 認知症外来の包括評価が充実
- 脳卒中超急性期リハの評価強化
  （3日以内 60点）
- 指定難病の遠隔診療が全面可能に
- 回復期リハ入院料の増点
- 休日リハ加算で365日体制
- ベースアップ評価料の増収

注意が必要な変更

- 早期リハ加算の期間短縮
  （30日→14日）
- 回復期リハ実績指数の引き上げ
- FIM認知除外基準の厳格化
- 離床困難患者のリハ減算
  （医学的理由の記載要）
- リフィル処方箋の掲示義務

3つの軸: 「認知症の包括管理」「急性期リハの集中化」「神経難病の遠隔医療」

令和8年6月1日施行 — 各施設での体制整備と算定準備を

ご視聴ありがとうございました

チャンネル登録・高評価をお願いします

参考文献

1. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
2. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料」
3. 厚生労働省 疑義解釈資料（その1・その2）
4. GemMed 2026年度診療報酬改定答申シリーズ